

差异有统计学意义($P<0.01$),血糖差异无统计学意义($P>0.05$),对照组治疗前后自身对比,血糖差异显著,血压、尿蛋白差异无统计学意义。

表 1 两组患者治疗前后各项数据比较($\bar{x}\pm s$)

组别	BP (mmHg)	尿蛋白 (mg·d ⁻¹)	UAER (Lg·min ⁻¹)	血糖 (mmol·L ⁻¹)
实验组 治疗前	166.4±6.3/100.6±6.1	155.58±66.26	97.2±34.1	5.7±2.4
(28例) 治疗后	116.8±4.2/ 81.4±5.3 *	69.23±33.84 *△	22.4± 9.6 *△	5.1±2.2 *
对照组 治疗前	164.6±5.9/100.4±5.7	149.23±63.66	95.8±24.6	5.7±2.7
(26例) 治疗后	122.3±6.1/ 83.5±5.2	142.74±69.38	46.0±14.2	5.2±2.6 *

注:与本组治疗前比较,* $P<0.01$,与对照组治疗后比较,△ $P<0.01$

3 讨论

蛋白尿水平是 DN 肾功能恶化最主要的危险因素^[1],对肾脏长期预后影响极大,蛋白尿又与血压正相关。现已证实,肾小球内“三高”即高滤过、高血压及高灌注使尿白蛋白增高是早期 DN 的主要原因。降低血管紧张素对血压和肾小球血液动力学的影响,降低小球跨膜压;阻断血管紧张素 II (Ang II) 对肾小球内皮细胞的促增殖及系膜基质的沉积作用,防止肾小球肥大及纤维化减少 DN 患者尿白蛋白减缓下降的速率^[2,3]。近年来,大量试验及临床研究均已表明:控制肾小球系膜细胞的肥大和 Ang II 生成是延缓糖尿病肾病进展的关键^[4]。使用 Ang II 1 型受体阻滞剂,既可降低血压,又能降低肾小球囊内压,减轻系膜细胞增生,从而减少尿蛋白,保护肾功能,延缓慢性肾脏病的进展。

百令胶囊是采用生物工程方法分离的冬虫夏草菌种,经低温发酵精心研制的纯中药制剂,主要成分是“人工虫草菌粉”,与天然虫草主要成分一致,含有腺苷,多种氨基酸,虫草多糖,虫草酸,麦角甾醇,多种维生素和微量元素等成分^[5]。

研究表明,人工虫草制剂百令胶囊可以显著增强免疫机能受损患者的抗感染能力,可抑制抗体与肾小球上皮细胞固有抗原原位结合,减少沉积,抑制激活补体形成复合体,降低了直接和间接对肾小球滤过屏障损伤作用^[6]。

研究结果显示,治疗前各项指标差异无统计学意义,治疗后,缬沙坦加百令胶囊组比对照组在血压、微量蛋白尿等指标方面均明显改善,差异显著,提示:百令胶囊与缬沙坦联用对治疗早期 DN 有协同作用,可使糖尿病肾病患者的血压控制良好,尿蛋白减少,并干预糖尿病肾病的预后,无明显副反应,可广泛应用于临床治疗早期 DN 患者,其机制可能与减轻微血管炎症,降低肾小球内高压有关。

参 考 文 献

1 Keane UF, Brenner BM, de Zeeuw D, et al. The risk of developing end-stage renal disease in patients with type 2 diabetes and nephropathy: the RENAAL study[J]. *Kidney Int*, 2003, 63: 1499-1507
2 Goto H, wakui H, Komatsuda A, et al. Renal alpha-actinin-4: purification and puromycin aminonucleoside-binding property [J]. *Nephron Exp Nephrol*, 2006, 93(1): e27-e35
3 张树俭,姚建. 血管紧张素 II 的损害效应及其 AT₁ 受体拮抗剂肾脏保护功能[J]. *中国中西医结合肾病杂志*, 2007, 4(7): 426-427
4 Jerums G, Allen TJ, Campbell DJ. Long-term comparison between perindopril and nifedipine in normotensive patients with type 1 diabetes and microalbuminuria[J]. *Am J Kidney Dis*, 2006, 37(5): 890-899
5 孙春雨,马红. 人工虫草制剂的临床应用现状[J]. *江苏中医*, 1997, 18(6): 45-47
6 段贵生,陈星华. ACEI 联合百令胶囊治疗肾性蛋白尿的疗效分析[J]. *临床肾脏病杂志*, 2006, 11 (26): 273

(2009-09-16 收稿 2009-11-30 修回)

皮肤科用药中几则药物相互作用的处方分析

车斌 谢为民 于剑辉 (福建省皮肤病性病防治院药剂科 福州 350009)

摘 要 目的:探讨皮肤科系统用药中有关药物的相互作用。方法:对我院 2008 年 7~12 月药剂师审核中发现的具有潜在药物相互作用的处方进行回顾性分析。结果:共收集有关药物相互作用的处方 156 张,占不合理用药处方的 16.12%,药物相互作用的方式涉及到药剂学、药动学、药效学等多方面因素。结论:药物相互作用是药物不良反应或毒性反应发生的重要原因,研究药物的相互作用对评价临床合理用药具有现实的指导意义。

关键词 皮肤科用药; 药物相互作用; 合理用药; 分析

中图分类号:R969.2 文献标识码:A 文章编号:1008-049X(2010)04-0552-04

Retrospective Analysis of Some Prescriptions with Drug Interactions in Dermatological Agents

Che Bin, Xie Weimin, Yu Jianhui (Dept. of Pharmacy, Fujian Dermatovenereology Hospital, Fuzhou 350009, China)

ABSTRACT Objective: To explore drug interactions of systemic medication in Dept. of Dermatology. Method: Retrospective analysis of prescriptions with latent drug interactions were performed in our hospital during July and December 2008, these prescriptions were discovered by pharmacists auditing. Result: The total of prescriptions with latent drug interactions was 156, accounted for 16.12% of the irrational drug use, the models of drug interactions involved in pharmaceutics, pharmacokinetics and pharmacodynamics. Conclusion: The ADR or drug toxicity is important reason for drug interactions, and drug interactions study has a guiding significance about the evaluation of rational drug use.

KEY WORDS Dermatological agents; Drug interactions; Rational drug use; Analysis

药物相互作用 (drug interactions) 是指两种或两种以上的药物同时服用时,引起的其中一个或几个药物的效应的改

通讯作者:车斌 Tel: (0591) 83255860 E-mail: fjdh-yao@tom.com

变,即产生协同、相加、拮抗等作用。合理的药物相互作用可以增强疗效或降低不良反应,反之可导致疗效降低或毒性增加,加重病情。药剂师对方合理性进行审核是《药品管理法》赋予药剂师的一项职责,《处方管理办法》第三十五条也规定了“药师应当对方用药适宜性进行审核,审核内容包括:是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌”。笔者长期从事皮肤科门诊处方的审核工作,对工作中收集的有药物相互作用的案例进行回顾性分析,以期能促进合理用药工作在皮肤科的开展。

1 资料和方法

处方来源于 2008 年 7~12 月我院药剂师对不合理用药处方的审核及登记。处方分析采用 2007 年 5 月新修订的《处方管理办法》及卫生部《抗菌药物临床用药指导原则》等法规为依据。

2 结果

2.1 潜在药物相互作用处方的分类统计

共收集了不合理用药处方 968 张,占同期门诊处方的 1.07%,其中存在潜在药物相互作用的处方有 156 张,占不合理用药处方的 16.12%。我院处方潜在药物相互作用的分类统计情况见表 1。

表 1 潜在药物相互作用处方的分类统计

药物相互作用类型	处方数(例)	百分比(%)
药剂学方面的相互作用		
注射溶媒选择不当	7	4.49
药动学方面的相互作用		
影响药物的吸收	35	22.44
影响药物的分布	2	1.28
影响药物的代谢	41	26.28
影响药物的排泄	10	6.41
药效学方面的相互作用		
敏感化现象的药物联用	3	1.92
作用于同一受体的药物联用	27	17.31
药理效应的拮抗作用	13	8.33
药理效应的协同作用	18	11.54
合计	156	100.00

2.2 药剂学方面的相互作用

许多药物配伍后在药剂学上会发生分解、取代、聚合、加成等化学反应,难以从外观上分辨出来,尤其是注射剂出于稳定性的考虑,制作过程中可能会加入不同的溶媒或增溶剂。无指征的混合注射药品具有极高的风险性,因为药物配伍后,溶媒发生了改变,会使得药物溶解度改变,进而析出结晶,当微粒进入微血管后会引发栓塞,可导致周围循环障碍等严重的不良反应。如注射用乳糖酸阿奇霉素+5%葡萄糖注射液。乳糖酸阿奇霉素为白色疏松粉末,静滴时宜用适量注射用水充分溶解,配制成 0.1g·ml⁻¹,再加入氯化钠注射液中,乳糖酸阿奇霉素的 pH 为 6.0~7.5,若要加入偏酸性的葡萄糖溶液中,必须每 100 ml 溶液中加入 4% 碳酸氢钠 1 ml。我院不良反应监测中心曾接到过 2 例注射乳糖酸阿奇霉素引起患者头痛、呕吐等不良反应的报告,经审核后发发现处方中均未开具注射用水及碳酸氢钠,而是直接将阿奇霉素溶于葡萄糖注射液中,这样易导致乳糖酸阿奇霉素分解或析出沉淀,因此乳糖酸阿奇霉素不宜与葡萄糖注射液直接配伍。

2.3 药动学方面的相互作用

2.3.1 药物联用影响药物的吸收 包括影响胃肠道 pH、

改变胃排空或肠蠕动速度、药物相互结合后妨碍吸收、改变肠粘膜的转运功能、改变肠道内菌群及影响药物肝肠循环等。如伊曲康唑胶囊+雷尼替丁胶囊。伊曲康唑为三唑类的抗真菌药物,脂溶性强,餐后立即服用,生物利用度高,与含油脂类食物同服,更有利于药物的吸收,应避免与抑制胃酸分泌的药物联用,如抗胆碱能药、抗酸药、H₂ 受体拮抗药等。雷尼替丁属 H₂ 受体拮抗药,可用于慢性荨麻疹的联合治疗,但其可改变胃肠道的 pH,影响其他药物的解离,进而影响药物在小肠中的吸收,两药联用应间隔 2 h 以上。刘志军等^[1]总结了食物对某些抗感染药物吸收的影响,主要是导致抗感染药物生物利用度的改变,包括药物的达峰时间、达峰浓度以及 AUC 等参数的变化,认为应重视患者的饮食结构对抗感染药物疗效的潜在影响。

2.3.2 药物联用影响药物的代谢 药物代谢方面的相互作用,包括药物的首过作用、酶促作用、酶抑作用等。如罗红霉素片+咪唑斯汀片。罗红霉素为大环内酯类抗生素,会抑制由细胞色素 3A 酶催化的药物代谢,导致联用药物的作用增强或延长,包括副作用。咪唑斯汀是一种强效的、高选择性的组胺 H₁ 受体拮抗药,主要在肝脏经葡萄糖醛酸化和硫酸化代谢,也有通过肝脏 CYP3A4 代谢的途径,形成无活性的羟基化代谢产物。因此大环内酯类抗生素(如红霉素、罗红霉素、克拉霉素等)与咪唑斯汀、阿司咪唑、特非那定等联合使用时,会干扰目标药物的代谢,引起 QT 间期延长的现象,增加高危人群发生心律失常的风险,因此罗红霉素与咪唑斯汀不宜联用。黎明江等^[2]总结了非抗心律失常药物所致的心律失常,其中就包括大环内酯类抗生素、唑类抗真菌药物以及抗组胺药物等。大环内酯类抗生素与 H₁ 受体拮抗药联用在湿疹及特应性皮炎的治疗中很常见,因大环内酯类抗生素有抗炎作用,对具有超抗原性质的金葡菌有较强的抑制作用,若要与 H₁ 受体拮抗药联用,建议选用无首过效应的西替利嗪,其消除方式为约 70% 以药物原形随尿液排出体外。

2.3.3 药物联用影响药物的排泄 如克拉霉素片+甲氨蝶呤片。克拉霉素为大环内酯类抗生素,对细胞色素 P450 酶的 CYP3A4 和 P-糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp)转运系统均有抑制,会增加甲氨蝶呤的生物利用度,尤其对慢性肾功能不全的患者,会造成肾功能的损害,因此克拉霉素与甲氨蝶呤不宜联用。P-gp 具有广泛的底物特异性,能与多种结构不同的被动扩散到细胞内的药物和有毒物质结合,依靠 ATP 的转化能量将到达细胞内的药物和细胞毒性物质泵出,P-gp 在保护正常组织不被毒害同时,可将作用于靶点的药物浓度降低。药物排泄方面的相互影响,包括药物影响尿液 pH 的改变、肾小管主动分泌的改变、肾组织血流量改变、肾小球的滤过作用以及肾小管的被动重吸收等。对于治疗指数窄的药物,同时使用中草药、食物或维生素等,都可能影响 P-gp 的功,增加药物治疗的风险,如服用金丝桃或葡萄柚汁会明显增加抗肿瘤药物的风险^[3]。对于中重度银屑病使用甲氨蝶呤与大环内酯类抗生素联用时,可考虑使用阿奇霉素口服制剂,因为阿奇霉素主要以原形经胆道排出,不影响细胞色素 P450 酶和 P-gp 转运系统。

2.4 药效学方面的相互作用

2.4.1 敏感化现象的药物联用 即药物使组织或受体对

另一种药物的敏感性增强,如头孢哌酮注射液+氢化可的松注射液。患者在应用头孢哌酮、头孢唑林、头孢孟多、头孢美唑等药物期间口服或静脉应用含乙醇的制品,或用乙醇进行皮肤消毒、擦洗时,均可产生双硫仑样反应(disulfiram),表现为面部潮红、头痛、眩晕、心慌、呼吸困难、急性心衰、惊厥甚至死亡,症状出现于接触乙醇后5~40 min。氢化可的松注射液含50%乙醇,而上述头孢菌素类抗菌药物在化学结构上共同的特点是在其母核7-氨基头孢烷酸(7-ACA)环的3位上有甲硫四氮唑取代基,其与辅酶I竞争乙醛脱氢酶的活性中心,可阻止乙醇氧化成乙醛后的继续氧化,导致乙醛的蓄积,因此头孢哌酮注射液与氢化可的松注射液不宜联用。为避免两药联用引起的双硫仑样反应,临床可改用氢化可的松琥珀酸钠注射液代替氢化可的松注射液。吴静等^[45]报道了双硫仑样反应的发生与摄入乙醇的量无关,其中头孢菌素引起的双硫仑样反应临床上最常见,其次为硝基咪唑类。

2.4.2 作用于同一受体的药物联用 如氯雷他定片+赛庚啶片。氯雷他定系长效的三环类抗组胺药,与赛庚啶同属于三环类抗组胺药,此类药物尚有异丙嗪、酮替芬、多塞平等,联合用药可能增加对中枢的抑制作用,属重复用药,不宜联用。由于抗组胺药起效时间不同,为增强治疗效果,两种或两种以上抗组胺药联合使用,在皮肤科处方中很常见。临床上常将第一代既有镇静作用,且止痒效果好的H₁受体拮抗药,与第二代无镇静作用的H₁受体拮抗药药物联合使用,但所选用的药物应属于不同的化学结构类别。

2.4.3 药理效应的拮抗作用 如地氯雷他定片+青霉素皮试剂。地氯雷他定是氯雷他定在体内的主要活性代谢产物,具有长效、选择性的抑制外周H₁受体的抗组胺作用,其口服后30 min可测到血药浓度, $t_{1/2}$ 约为27 h。因抗组胺药能消除或减轻皮肤对所有变应原的阳性反应,可能会干扰青霉素皮内试验阳性结果的判断,故作青霉素皮试前48 h内应停止使用长效抗组胺药。青霉素类药物是治疗梅毒的首选药物,但较易产生不良反应,如皮疹、药物热、血管神经性水肿、血清病型反应、过敏性休克等,其中以过敏性休克最为严重。一旦发生,口服抗组胺药物无法阻止变态反应的发生,应采取综合的抢救措施。

2.4.4 药理效应的协同作用

2.4.4.1 引起颅内压增高 如异维A酸胶囊+米诺环素胶囊。异维A酸为13-顺式维A酸,它用于治疗痤疮时具有缩小皮脂腺组织,抑制皮脂腺分泌等功效。米诺环素可抑制痤疮丙酸杆菌,脂溶性高,易通过血脑屏障,常见不良反应有眩晕、耳鸣、共济失调、恶心、呕吐等前庭功能紊乱。因两药均可引起颅内压增高,联合使用严重时可能导致假性“脑瘤”的发生,出现高血压头痛、视觉障碍等症状^[6],因此异维A酸与米诺环素不宜联用。异维A酸与系统应用的糖皮质激素合用,也可能会诱发颅内压升高。口服维甲酸类药物还包括维胺脂、阿维A、维A酸等,均不宜与口服四环素类药物如四环素、多西环素等合用,特别值得关注的是长期或超量服用维生素A丸、维生素AD丸的婴幼儿^[7],也可发生良性颅内压增高症。

2.4.4.2 引起消化道溃疡 如甲泼尼龙片+吡哌美辛片。甲泼尼龙为人工合成的糖皮质激素,适应于变态反应性或自身免疫性等多种皮肤病的治疗,其不良反应会对消化道黏

膜,尤其是胃黏膜造成损伤,称为类固醇性溃疡,具有症状轻而出血率高、穿孔率高等特点。吡哌美辛为非甾体类抗炎药(NSAIDs),主要通过抑制环氧化酶的活性,使花生四烯酸不能经环氧化酶氧化成前列腺素,从而起到了抗炎、解热、镇痛的作用。环氧化酶(COX)有两种异构体:COX-1和COX-2,COX-1称为体质酶,存在于胃、肾、血小板中;COX-2称为诱导酶,作用于炎症部位,合成与炎症有关的前列腺素,NSAIDs的抗炎作用是由于抑制了COX-2,而胃粘膜刺激和肾毒性等不良反应是因为抑制了COX-1。联合用药易引起消化道溃疡、胰腺炎、食管炎等,严重时会造成胃出血或穿孔,因此甲泼尼龙与吡哌美辛不宜联用。陈葵^[8]认为应激性溃疡的发生是多因素的结果,排在前三位的是:NSAIDs(占病人总数的50%)、饮酒(30.2%)、激素(7%)。

3 讨论

3.1 皮肤科系统用药有其特殊的药代动力学,因为皮肤是富含角蛋白的组织,为提高药物的生物利用度,使其在周边室分布较多,常需餐后即刻服用药物或与脂溶性食物同服以利于吸收,如口服的咪唑类抗真菌药、维甲酸类药物等。同时由于多次给药,药物在皮肤中会有一定的蓄积作用,消除较慢,临床治疗上不能仅考虑药物的 $t_{1/2}$,往往血药浓度低至无法测定时,药物在皮肤的角质层、皮脂、汗腺中仍能维持一定的治疗浓度。

3.2 皮肤科系统用药中,许多药物的代谢影响细胞色素P450酶的活性,如大环内酯类抗生素、咪唑类抗真菌药、H₂受体拮抗药、甲硝唑以及利福平等,当这些药物与其他药物合用时,应调整剂量或错开服药时间。对于正在服用心血管用药或降血糖药的皮肤病患者,更应考虑药物相互作用可能产生的严重不良反应,如高血压危象、心律失常、低血糖反应等。Svecova L等^[9]研究了不同咪唑类抗真菌药对利福平诱导孕烷X受体(pregnant X receptor, PXR)介导的CYP3A4基因的转录表达的影响,揭示两药作用的方式为与PXR的相互竞争。从分子水平上对药物相互作用机制的研究表明,PXR作为关键的转录调控因子,参与了CYP3A4基因诱导的表达,即从配体激活的核受体转录因子延伸到药物代谢酶系统,目前该领域已受到药物研发和药物安全性评价的广泛关注。

3.3 药物之间的相互作用影响因素较多,体内药物相互作用远比体外复杂且隐蔽,间隔较长时间用药引起的相互作用,更易被人们所忽略。药物相互作用的方式涉及药剂学、药理学、药效学等相关学科的知识,有时是诸多因素共同作用的结果。在研究药物相互作用的同时,还应重视烟、酒等食物或饮料对药物作用的影响。目前临床用药中几乎不存在单用一种药物的情况,合并用药的核心是增强药效,减少用量,降低毒副作用。随着多种药物联用的增加,药物不良反应的发生率也明显上升,其中药物相互作用是药物不良反应或毒性反应发生的重要原因,应引起足够的重视,同时应发挥药师在处方审核中的作用,避免有害的药物相互作用的发生。

参考文献

- 1 刘志军,傅德兴.食物-抗感染药物的相互作用研究进展[J].临床药物治疗杂志,2007,5(3):42-49
- 2 黎明江,向晋涛.非抗心律失常药物的致心律失常作用[J].中国心脏起搏与心电生理杂志,2009,23(2):106-109

草分枝杆菌对尖锐湿疣患者 Th1/Th2 免疫平衡的调节作用

钟小娅 黄定蒙 (苍南县第三人民医院 浙江苍南 325800)

摘要 目的:观察草分枝杆菌对尖锐湿疣患者血清 IL-12 和 IL-4 水平的影响,探讨草分枝杆菌对尖锐湿疣患者 Th1/Th2 免疫调节作用的机制。**方法:**将 68 例尖锐湿疣患者随机分为治疗组和对照组。治疗组采用局部电灼术和肌注草分枝杆菌治疗,对照组只采用局部电灼术治疗。采用双抗体夹心 ELISA 法分别检测治疗前和治疗 3 个月后患者血清 IL-12 和 IL-4 水平的变化,并进行临床疗效的观察和生存质量的评估。**结果:**两组患者治疗前血清 IL-12 和 IL-4 水平比较差异均无统计学意义。治疗组治疗后血清 IL-12 水平较治疗前明显升高,血清 IL-4 水平明显降低($P < 0.05$);而对照组治疗前后却无明显变化。随访 3 个月治疗组有 4 例复发,对照组有 13 例复发,治疗组的复发率明显低于对照组($P < 0.05$)。两组患者治疗前生存质量评分比较差异均无统计学意义。治疗组治疗后生存质量评分明显提高,生理、心理、社会和环境 4 个领域的评分与治疗前比较均有明显增加($P < 0.05$),而对照组治疗前后却无明显变化。**结论:**草分枝杆菌能明显降低尖锐湿疣复发率,提高患者的生存质量。作用机制可能是通过影响 IL-12,IFN-r 和 IL-4,IL-10 等组成的细胞因子网络从整体上调节 Th1/Th2 免疫平衡和增强细胞免疫功能。

关键词 尖锐湿疣;草分枝杆菌;Th1/Th2 平衡;疗效;生存质量

中图分类号:R979.5 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-049X(2010)04-0555-03

Regulating Role of *Mycobacterium Phlei* F. U. 36 on Th1/Th2 Immune Balance in Patients with Condyloma Acuminatum

Zhong Xiaoya, Huang Dingmeng (Department of Obstetrics & Gynecology, Third People's Hospital of Cangnan City, Zhejiang Cangnan 325800, China)

ABSTRACT Objective: To observe the influence of *Mycobacterium Phlei* F. U. 36 on serum IL-12 and IL-4 levels and to explore its role in Th1/Th2 immune regulation mechanism in patients with condyloma acuminatum. **Method:** Sixty-eight cases of condyloma acuminatum were divided into treatment group and control group randomly. Treatment group was used local fulguration treatment and intramuscular injection of *Mycobacterium Phlei* F. U. 36. Control group; only used local fulguration treatment. Serum IL-12 and IL-4 levels were determined by Double-antibody sandwich ELISA before treatment and 3 months after treatment in patients, and clinical efficacy and quality of life were assessed. **Result:** There were no significant differences in serum IL-12 and IL-4 levels in the two groups of patients before treatment. Serum IL-12 levels were significantly increased after treatment, and serum IL-4 levels were significantly decreased in the treatment group; While there were no significant changes before and after treatment in the control group. After 3 months follow-up, four cases of recurrence were found in the treatment group while 13 patients relapsed in the control group. The relapse rate in the treatment group was significantly lower than that in the control group. There was no significant difference in quality of life score in the two groups of patients before treatment. After treatment, the quality of life score was significantly improved in physical, psychological, social and environmental areas and the score was significantly increased, while in the control group, no significant changes were found before and after treatment. **Conclusion:** *Mycobacterium Phlei* F. U. 36 can significantly reduce the relapse rate and improve the quality of life of patients with condyloma acuminatum. Its mechanism may be through its influence on IL-12, IFN-r and IL-4, IL-10 and other components of the cytokine network which regulate the overall balance of Th1/Th2 immune cells and enhance immune function.

KEY WORDS Condyloma acuminatum; *Mycobacterium Phlei* F. U. 36; Th1/Th2 balance; Efficacy; Quality of life

尖锐湿疣是由人乳头瘤病毒(HPV)引起的一种常见性传播疾病,其治疗后复发率高,且尖锐湿疣复发与某些生殖器鳞癌的发生密切相关。研究证实尖锐湿疣的发生、发展和转归不仅与 HPV 感染有关,而且与宿主的细胞免疫功能状

态相关。近年来对尖锐湿疣患者细胞免疫功能的研究显示存在 Th1/Th2 免疫失衡^[1,2]。草分枝杆菌是一种多功能免疫增强药,主要通过影响免疫应答反应来调节免疫功能^[3]。近年来研究发现其对尖锐湿疣有一定的疗效,但具体作用机

通讯作者:钟小娅 Tel:13757888099 E-mail:cangnanzhongxy@126.com

3 Marchetti S, Mazzanti R, Beijnen JH, et al. Concise review: Clinical relevance of drug drug and herb drug interactions mediated by the ABC transporter ABCB1 (MDR1, P-glycoprotein) [J]. *Oncologist*, 2007, 12(8): 927-941
4 王丽君. 注射头孢曲松致双硫仑样反应 1 例[J]. *药物流行病学杂志*, 2006, 15(1): 45
5 吴静, 郑雪冰, 孙晓莉. 急诊救治双硫仑样反应 92 例临床分析[J]. *中国实验诊断学*, 2009, 13(6): 763-765
6 中国医师协会皮肤科医师分会《中国痤疮治疗指南》专家组. 中国痤疮治

疗指南(讨论稿)[J]. *临床皮肤科杂志*, 2008, 37(5): 339-342
7 陈小聪, 张雯, 肖芳绵. 婴幼儿良性颅内压增高症 78 例诊治分析[J]. *陕西医药杂志*, 2004, 33(7): 614-615
8 陈莹. 应激性溃疡 86 例临床分析[J]. *医学信息*, 2009, 22(6): 1020-1021
9 Svecova L, Vrzal R, Burysek L, et al. Azole antimycotics differentially affect rifampicin-induced pregnane X receptor-mediated CYP3A4 gene expression[J]. *Drug Metab Dispos*, 2008, 36(2): 339-348
(2009-09-01 收稿 2009-12-25 修回)